

Refluxo GE · fisiológico × DRGE

Regurgitação sem sofrimento é fisiológica na maioria dos lactentes. DRGE implica sintomas ou complicações — evite medicar refluxo benigno.

Medidas iniciais

Dica - Medidas iniciais

Espessar seletivamente, volumes menores e mais frequentes, evitar tabaco, manter aleitamento. Elevação do berço tem evidência fraca — cuidado com sono seguro (decúbito dorsal).

Ramificação: tranquilizar e posicionar versus investigar alarme e tratar complicação.



Sinais de alarme

- Vômito bilioso, hemático ou em jato persistente
- Má evolução ponderal, anemia, arquearão com choro (Sandifer)
- Sintomas respiratórios graves / ALTE-BRUE associados
- Início após 6 meses ou piora progressiva — pensar outras causas

Conduta farmacológica

Cenário | Papel

Refluxo fisiológico | Sem IBP/pró-cinético de rotina

Esofagite / DRGE clara | IBP em curso definido

Suspeita de APLV | Teste de exclusão antes de cronificar IBP

Estenose hipertrófica | USG; cirurgia — não é 'refluxo'

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Não use IBP empírico prolongado em lactente 'que cuspe'. Vômito bilioso = obstrução até prova em contrário.

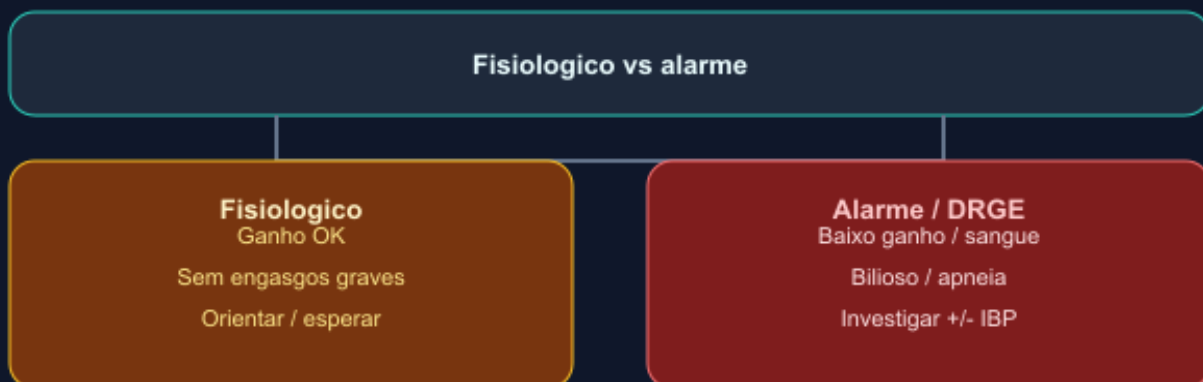
Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Sinais de alarme separam regurgitação fisiológica do lactente de DRGE/obstrução que precisam investigar — e evitam IBP empírico eterno.

Ganho ponderal bom e ausência de alarme = orientação. Bilioso, hemático, falha de crescimento = investigar.

Refluxo do lactente



Qualquer item de alarme muda o fluxo: imagem, exclusão de APLV ou avaliação cirúrgica conforme o quadro.

Sinais de alarme

Não é só cuspe

- 1 Vômito bilioso ou hematemese
- 2 Má evolução ponderal / anemia
- 3 Apneia / BRUE associados
- 4 Jato persistente (estenose?)
- 5 Início após 6 meses ou piora progressiva
- 6 Sinais de abdome cirúrgico

Bilioso = obstrução até prova em contrário

Conduta

Cenário | Papel

Fisiológico | Sem IBP/pró-cinético de rotina

DRGE/esofagite | IBP em curso definido

Suspeita APLV | Exclusão antes de cronificar IBP

Estenose pilórica | USG; cirurgia

Medidas iniciais

- Volumes menores e mais frequentes; manter aleitamento
- Espessar seletivamente; evitar tabaco
- Sono seguro em decúbito dorsal — elevação tem evidência fraca

Armadilha

Atencao - Armadilha

IBP empírico prolongado em lactente que 'cuspe' sem alarme não é boa medicina nem boa prova.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.
www.medhubr1.com.br - MedHub R1